

La incontinencia urinaria de esfuerzo es el escape de orina cuando algo ejerce presión repentina sobre la vejiga — toser, estornudar, reír, levantar peso o hacer ejercicio. En las mujeres ocurre cuando se debilita el soporte que hay debajo de la uretra, a menudo después del parto o de la menopausia. Es muy común y muy tratable, desde ejercicios sencillos hasta una cirugía rápida y muy eficaz.

Acerca de esta afección

La **uretra** (el conducto por el que sale la orina) normalmente se mantiene cerrada cuando usted tose o hace fuerza, gracias al soporte del suelo pélvico y a los tejidos que la rodean. Cuando ese soporte se debilita, un aumento repentino de la presión del vientre empuja la orina hacia afuera. La señal característica es **el escape con la actividad** — no con unas ganas repentinas (eso es la vejiga hiperactiva; tener las dos cosas se llama incontinencia **mixta**).

Qué la causa

- **El embarazo y el parto** (una de las causas principales)
- **La menopausia** y el envejecimiento
- Tos crónica, estreñimiento o levantar peso con frecuencia
- El exceso de peso corporal y cirugías pélvicas previas

APRENDA LOS TÉRMINOS

Incontinencia de esfuerzo

Escape de orina con la presión — al toser, levantar peso, hacer ejercicio.

Uretra

El conducto que lleva la orina fuera del cuerpo.

Suelo pélvico

Los músculos que dan soporte a la vejiga y la uretra.

Ejercicios de Kegel

Ejercicios de contracción del suelo pélvico que refuerzan el soporte.

Incontinencia mixta

Tener escapes de esfuerzo y de urgencia a la vez.

Pesario / dispositivo

Un pequeño soporte que se coloca en la vagina para reducir los escapes.

Agente de relleno uretral

Una inyección en consulta que ayuda a que la uretra selle.

Cabestrillo mediouretral

Una pequeña malla de soporte que se coloca bajo la uretra en cirugía.

¿NECESITO CIRUGÍA? No necesariamente. Muchas mujeres mejoran con ejercicios del suelo pélvico y cambios sencillos, y algunas usan un dispositivo de soporte. La cirugía (como un cabestrillo) es muy eficaz cuando quiere una solución más duradera — pero es su decisión, y puede empezar por los pasos más sencillos.

Cómo se diagnostica

- Una conversación sobre cuándo tiene escapes y un examen (a veces una prueba de tos)
- Un **análisis de orina** para descartar infección, y una revisión de qué tan bien vacía la vejiga
- A veces, una prueba de función de la vejiga (urodinamia) antes de la cirugía

Cómo se trata (paso a paso)

- 1 **Ejercicios del suelo pélvico** (Kegel) y fisioterapia, bajar de peso y tratar la tos o el estreñimiento.
- 2 **Dispositivos de soporte** — un pesario vaginal o un dispositivo de venta libre.
- 3 **Relleno uretral** — una inyección rápida en consulta que ayuda a que la uretra selle.
- 4 **Cirugía** — un **cabestrillo mediouretral** (o un cabestrillo de tejido propio) para una reparación duradera. Cada opción tiene su propia hoja informativa.

Vivir con incontinencia de esfuerzo

- Aprenda a **apretar antes de toser, estornudar o levantar peso** ("el truco").
- Haga los ejercicios del suelo pélvico a diario — puede tardar de 6 a 12 semanas en notar mejoría.
- Trate el estreñimiento y la tos crónica, que aumentan la presión.

Llame a su equipo si tiene:

- Ardor, urgencia o **sangre en la orina** (posible infección)
- Escapes también con unas **ganas fuertes** — el tratamiento puede ser distinto
- La sensación de que la vejiga no se vacía

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La incontinencia de esfuerzo en la mujer es el escape con la presión por un soporte debilitado bajo la uretra — común y muy tratable.
2. Las opciones van desde ejercicios del suelo pélvico y un dispositivo de soporte, hasta una inyección de relleno en consulta o un cabestrillo para una solución duradera.
3. Los ejercicios tardan semanas en funcionar; apriete antes de toser o levantar peso. La cirugía es una opción, no una obligación.